

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS 22222363615 | 030

CELSO APARECIDO BUENO SERRANO

IDADE: 54 PESO: 85 ALTURA: 170 PROFISSÃO: Comerc.
SINTOMAS: Sonolência Diurna / Memória.
QUEIXAS: Dor de cabeça.
MEDICAMENTOS: Dupixent
HAS / glaucoma
MÉDICO: Dr. Andreu
EXERCÍCIO FÍSICO: Tênis 3X
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 20
HORA QUE DORME: 22-23 HORA QUE ACORDA: 6h
COCHILHO ☒ SIM () NÃO 1h DORME ACOMPANHADO () SIM ☒ NÃO () EVENTUAL
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM ☒ NA SEMANA () NÃO
FUMO ☒ SIM () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 3X
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: gorda CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: SPO2:

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

() ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS

Dor nas articulações
22/01/24

29/07/24 - Comprou o CPAP Elite

Parou por motivo de esquecimento, parou e/ o uso da canabiz 2

- Tere uma situação final do ano, aí o final
cero deve uma separação.

Há 1 ano 3 meses / Acorda 7:30 - Caminha 1 hora - Banho
Toma café - Deita - Almoço - Fuma - Fica em
Fuma
Banho na rua de obra.
7 dias com mais esquecimento.

05/08/25 Orientei - Neuro / Psia.
Diário sono / Exerc. físico / ativi// na
casa.

Dr. Alvaro Nakano - CRM 84.287

Dra. Andréia A. Bisanha - CRM 112.331

CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO
NAKANO MEDICINA
LASER THERAPY

Imuniterapia

(vacina para alergia)

teste cutâneo para alergia

PRICK TEST

Encaminhado CELSO APARECIDO BUENO
SERRANO para adaptação de CPAP.

Pressão de titulação: 10cm H2O

Grata.



Microagulhamento

Biorevitalização

Intradermoterapia

Preenchimentos



Fonoaudióloga

Otorrinolaringologia

Audiometria

Impedânciometria

Emissões Otoacústicas

(teste da orelhinha)

BERA

Eletrococleografia

Vectoeletronistagmografia

Processamento Auditivo Central

Vídeo Estroboscopia de Laringe

Vídeo Endoscopia Nasossinusal

Vídeo Laringoscopia com foto

Dra. Andréia A. Bisanha
CRM 112331
Otorrinolaringologia

CID 10: _____

Autorizo a Informação.

CONSULTA DIA: _____

NAKANO MEDICINA SOC. EMP. LTDA ME - CNPJ 04.518.000/0001-39

CARAGUATATUBA:

Av. Dr. Arthur Costa Filho, 937 - Sala 24/25 - 2º andar
Caraguá Praia Shopping - Tel.: 12 3883.3849

www.nakanomedicina.com.br
contato@nakanomedicina.com.br

DR. ALBERTO REMESAR

PSIQUIATRIA

LAUDO DA POLISSONOGRAMA

NOME: Celso Aparecido Bueno Serrano

EXAME nº: 5340-2 CPAP

SOLICITADO POR: Dra. Andreia Alessandra Bisanha

DATA: 04/10/2023

IDADE: 53 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h04min e concluído às 04h11min. A latência para o sono foi de 1 minuto e a latência para o estágio REM, de 112 minutos. O tempo total de sono foi de 328,5 minutos (05h28min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 91,9%. A distribuição do sono mostrou 10,5% de estágio 1, 62,4% de estágio 2, 11,7% de estágio 3 e 15,4% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 28 minutos em vigília, ocorreram 102 microdespertares (índice: 18,6/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 7,9/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 19,7/hora, sendo 3,3 apneia/hora e 16,4 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 19,7/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 91%, sendo a saturação média de 92% e a mínima de 80%.

(*) TTS⇒ Tempo Total de Sono

TTR⇒ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

O paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ele usou a máscara nasal Mirage Activa medium (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 10 cm de H₂O.

Ele relatou que sentiu muito desconforto com o uso da máscara.

Registraram-se aumentos moderados dos índices de apneia/hipopneia (19,7/hora; índice moderado: 15 a 30/hora) e de distúrbio respiratório (19,7/hora), episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 58; máxima: 71 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 1 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava normal (112 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono manter-se no limite da normalidade (91,9%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (índice: 18,6/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento da porcentagem do estágio 2 (62,4%; normal: 45-55%) e a redução do estágio REM (15,4%; normal: 20%). As porcentagens dos estágios 1 (10,5%; normal: 8-10%) e 3 (11,7%; normal: 10-12%) permaneceram nos limites da normalidade.

O índice de movimentos periódicos de membros (7,9/hora; índice normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade.

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Celso Aparecido Bueno Serrano

EXAME nº: 5340

SOLICITADO POR: Dra. Andreia Alessandra Bisanha

DATA: 24/03/2023

IDADE: 53 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h31min e concluído às 05h27min. A latência para o sono foi de 7 minutos e a latência para o estágio REM, de 75 minutos. O tempo total de sono foi de 332 minutos (05h32min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 80,8%. A distribuição do sono mostrou 20,8% de estágio 1, 31,6% de estágio 2, 16,6% de estágio 3 e 31% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 71,5 minutos em vigília, ocorreram 191 microdespertares (índice: 34,5/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 14,1/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 58/hora, sendo 39,4 apneia/hora e 18,6 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 58/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 93%, sendo a saturação média de 89% e a mínima de 61%.

(*) TTS = Tempo Total de Sono

TTR = Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (58/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (58/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, principalmente durante o decúbito dorsal, despertares e ritmo cardíaco sinusal. As frequências cardíacas foram: mínima: 49; máxima: 69 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de médio a alto.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

O paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 7 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava normal (75 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 80,8%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 34,5/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (20,8%; normal: 8-10%), 3 (16,6%; normal: 10-12%) e REM (31%; normal: 20%), e a redução do estágio 2 (31,6%; normal: 45-55%).

O índice de movimentos periódicos de membros (14,1/hora; índice normal até 15/hora) permaneceu no limite da normalidade.

Escala de Sonolência de Epworth: 5 (normal até 9; máxima: 24).

Bom dia, segue exame Sr. Celso Aparecido Bueno Serrano.